

TEMA 5.3 • OFTALMOLOGÍA

conjuntivitis especiales

PERFIL EUNACOM 6.02.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Conjuntivitis Bacteriana Crónica

- Lo fundamental para el médico general es entender que este cuadro clínico existe y no subdiagnosticarlo como si fuera un simple ojo seco o alergia mal tratada.
- **Clínica:** es similar a una **Conjuntivitis Bacteriana** aguda pero de presentación arrastrada con meses de evolución. Los síntomas son crónicos, frustrantes y de intensidad errática. Al no ser alarmantes, el paciente tarda meses en consultar, cronificando aún más la fisiopatología.
- **Diagnóstico:** es estrictamente clínico visual.
- **Tratamiento:** incluye antibióticos tópicos por tiempo extendido.
- **Clave del Manejo:** Tratar la **causa de base**. Una conjuntivitis bacteriana convencional no tiende a la cronicidad, por consiguiente algo está manteniendo la inflamación.
 - Mal aseo ocular (enseñar higiene de base)
 - Mala higiene y manejo de **lentes de contacto**.
 - **Blefaritis:** Inflamación mantenida en la base de las pestañas que entrega siembras bacterianas constantes al ojo.

Conjuntivitis por *Chlamydia Trachomatis*

A diferencia de la mayoría de las conjuntivitis, la **Chlamydia Trachomatis** (agente común de infecciones de transmisión sexual ETS) es patógena para los ojos en dos cuadros distintivos.

1. Tracoma (Variante Crónica Global)

- **Epidemiología:** Muy poco común en Chile (prácticamente ausente). Endémico de países en vías de desarrollo y de extrema pobreza. - **Transmisión:** Por contacto directo ojo-mano-ojo, no estrictamente de origen sexual. - **Clínica Inicial:** Cuadro muy inespecífico parecido a una conjuntivitis crónica. - **Complicaciones (Etapas Avanzadas):** A lo largo de meses o años culmina en cicatrización destructiva de la conjuntiva y los anexos: 1. **Entropión:** el párpado se invierte o rota hacia adentro. 2. **Triquiasis:** las pestañas apuntan hacia el globo frotando insidiosamente la córnea en cada parpadeo. 3. **Queratitis o Ulceras Corneales** severas producto del traumatismo continuo. - **Consecuencia Ciega:** Es una de las etiologías principales de ceguera evitable en países pobres.

2. Conjuntivitis Neonatal por Chlamydia

Cuadro infeccioso vertical y transmitido en el canal del parto, y algo clásico en los servicios de pediatría y neonatología en Chile. - **Cronología:** Su principal característica es el peculiar **periodo de latencia prolongado** postparto. El enrojecimiento ocurre invariablemente a la **1 o 2 semanas** de vida (entre 5 a 14 días), a diferencia del gonococo, que es extremadamente rápido y agudo en sus manifestaciones. - **Secreción:** Suele orientarse a una secreción de tipo **serosa** o discretamente blanquecina purulenta. - **Diagnóstico confirmatorio:** **PCR para Chlamydia**. - **Tratamiento:** Precisa antibióticos de orden netamente **sistémico**. - De elección estándar es un macrólido como la eritromicina sistémica en neonatos o azitromicina. - (Nota: La doxiciclina está estrictamente contraindicada en neonatos e infantes y recién se considera en adultos).

Conjuntivitis Hiperaguda (Gonocócica)

El nombre del cuadro "Hiperaguda" denota su extremada urgencia diagnóstica y terapéutica. Ante cualquier manifestación de este tipo asuma que el responsable es el *Neisseria gonorrhoeae* (Gonococo). Es de extrema gravedad; una derivación oportuna y manejo rápido salva el ojo.

- **Complicación de cuidado:** Presenta un enorme y real riesgo de **deshacer la córnea (absceso/úlceración severa)** y de crear **adherencias palpebrales irreversibles** si no es atacada rápidamente (quedando literalmente el párpado pegado y soldado al globo ocular de forma permanente).
- **Clínica Típica:**
 - Producción **copiosa** y abrumadora de materia y **pus densa**.
 - Signos de extrema inflamación orbitaria: gran edema palpebral y quemosis (edema conjuntival severo) a gran velocidad.
 - Hiperemia general marcada.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Contextos Epidemiológicos Clave para buscar una Hiperaguda 1. Recién Nacido a Término: Infectado verticalmente por madre con gonorrea no pesquizada en cuello uterino/vagina. Usualmente a los **primeros 2-5 días de nacido (incluso el mismo día)**. (Periodo de latencia brevísimo, marcando la gran diferencia con la infección por clamidia). 2. **Adultos (ITS):** Autoinoculación subsecuente a cuadros activos de uretritis supurativa. En estos sujetos habitualmente coexiste el cuadro de disuria supurada y el cuadro ocular hiperagudo.

Abordaje e Indicaciones Médicas

- **Diagnóstico Médico Legal y Definitivo:** El estándar de oro es **PCR para Gonococo**. No obstante, en un contexto de urgencia oftalmosistémica que suelta secreciones constantes, el **Gram de secreción ocular** provee un rendimiento inmediato excelente (Diplococos gramnegativos intracelulares) permitiendo iniciar un agresivo tratamiento dirigido antes de recibir PCR.
- **Tratamiento en Adulto:**
 - Abordaje general de la Infección de Transmisión Sexual (**Gonorrea**).
 - Monofármaco empírico: **Ceftriaxona intramuscular** en dosis aguda (Clásicamente 250 a 500 mg dosis única, con algunas guías actuales sugiriendo Ceftriaxona 500mg - 1 gramo si paciente es alto peso, IM).
 - Añadir soporte para la erradicación biológica del globo lo más temprano posible con **antibióticos tópicos agresivos**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un recién nacido de ocho días de vida presenta ojo rojo bilateral con secreción purulenta y edema palpebral. La madre tiene antecedente de infección de transmisión sexual durante el embarazo no tratada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento correcto?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para conjuntivitis especiales. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La conjuntivitis bacteriana crónica que no responde a antibióticos tópicos de primera línea debe hacer sospechar agentes especiales.
- La conjuntivitis neonatal por *Chlamydia trachomatis* se presenta entre los cinco y catorce días de vida por transmisión vertical durante el parto.
- El diagnóstico de la conjuntivitis por *Chlamydia* se hace con PCR y el tratamiento es doxiciclina, incluyendo madre y pareja sexual.
- El tracoma por *Chlamydia* es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo, prevalente en países en vías de desarrollo.
- La conjuntivitis gonocócica hiperaguda es una emergencia con secreción purulenta masiva de inicio muy brusco y riesgo de perforación ocular.
- El tratamiento de la conjuntivitis gonocócica es ceftriaxona intramuscular doscientos cincuenta a quinientos miligramos más irrigación ocular copiosa.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONJUNTIVITIS ESPECIALES)**PREGUNTA 1**

Un recién nacido de ocho días de vida presenta ojo rojo bilateral con secreción purulenta y edema palpebral. La madre tiene antecedente de infección de transmisión sexual durante el embarazo no tratada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento correcto?

- A)** Conjuntivitis viral por herpes simple, tratamiento con aciclovir tópico
- B)** Conjuntivitis bacteriana común, tratamiento con cloranfenicol tópico
- C)** Conjuntivitis por *Chlamydia trachomatis*, tratamiento con doxiciclina sistémica
- D)** Dacriocistitis neonatal, tratamiento con masaje del saco lagrimal
- E)** Conjuntivitis alérgica neonatal, tratamiento con antihistamínicos tópicos

PREGUNTA 2

Un hombre de veinticinco años consulta a urgencias por ojo rojo derecho de inicio esta mañana con secreción purulenta masiva casi explosiva, edema palpebral severo y adherencias conjuntivales. Refiere relaciones sexuales sin protección hace diez días. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Indicar antibióticos tópicos y control ambulatorio en tres días
- B)** Administrar ceftriaxona intramuscular e irrigación ocular copiosa
- C)** Solicitar cultivo y esperar resultado antes de tratar
- D)** Aplicar corticoides tópicos para reducir la inflamación
- E)** Derivar electivamente al oftalmólogo para la semana siguiente

PREGUNTA 3

En el contexto de las conjuntivitis especiales, el tracoma es una entidad que el médico general debe conocer. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tracoma es correcta?

- A)** Es producido por *Neisseria gonorrhoeae* y se presenta como conjuntivitis hiperaguda
- B)** Es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo y es prevalente en países en vías de desarrollo
- C)** Afecta exclusivamente a neonatos en los primeros catorce días de vida
- D)** Se trata únicamente con antibióticos tópicos sin necesidad de tratamiento sistémico
- E)** Su diagnóstico se confirma con examen directo con lámpara de hendidura

RESUMEN: CONJUNTIVITIS ESPECIALES

Las conjuntivitis especiales son aquellas que no corresponden a los tres tipos habituales y que tienen características clínicas, etiológicas y terapéuticas particulares que el médico general debe conocer. La primera categoría es la conjuntivitis bacteriana crónica, que es aquella que no responde al tratamiento habitual con antibióticos tópicos de primera línea y que debe hacer sospechar un agente etiológico específico. La segunda y más importante categoría corresponde a las conjuntivitis por *Chlamydia trachomatis*, que tiene dos presentaciones distintas. En países en vías de desarrollo, la infección por ciertas cepas de *Chlamydia* produce el tracoma, que es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo. En el contexto chileno, la presentación más relevante es la conjuntivitis neonatal por *Chlamydia*, que se produce por transmisión vertical durante el parto y se presenta típicamente entre los cinco y catorce días de vida. El diagnóstico se hace con PCR y el tratamiento es con doxiciclina, que debe extenderse también a la madre y a la pareja sexual. La tercera categoría es la conjuntivitis gonocócica hiperaguda, producida por *Neisseria gonorrhoeae*. Es una emergencia oftalmológica ya que puede progresar rápidamente a úlcera corneal con perforación y pérdida del ojo en horas. Se caracteriza por secreción purulenta masiva de inicio muy brusco y adherencias conjuntivales. El tratamiento es con ceftriaxona intramuscular en dosis de doscientos cincuenta a quinientos miligramos más irrigación ocular.